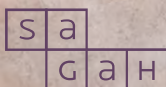


FARMÁCIA HOSPITALAR

Marcella Gabrielle Mendes Machado



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS



Qualidade na farmácia hospitalar

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Descrever os principais conceitos relacionados à qualidade em farmácia hospitalar.
- Explicar o processo de acreditação hospitalar.
- Listar indicadores de qualidade no processo de assistência farmacêutica.

Introdução

A avaliação dos serviços de saúde é necessária para que se apontem fragilidades e se identifiquem oportunidades de melhoria a fim de se ofertar uma assistência à saúde de melhor qualidade e mais humanizada. Nesse sentido, programas de qualidade vêm sendo frequentemente implantados com o objetivo de proporcionar o aumento da confiança dos clientes nos procedimentos oferecidos pelos hospitais. As instituições prestadoras de serviços de assistência à saúde que aderem ao processo de acreditação hospitalar revelam a sua responsabilidade em garantir a qualidade do atendimento à população, bem como o seu comprometimento em realizar todos os serviços com segurança e ética profissional.

Neste capítulo, você vai conhecer os principais conceitos relacionados à qualidade na assistência à saúde em unidades hospitalares, bem como ler sobre os fundamentos e as características do processo de acreditação hospitalar e dos indicadores de qualidade utilizados no contexto de assistência farmacêutica.

1 Qualidade hospitalar

A unidade hospitalar tem como missão primordial atender os seus pacientes da forma mais adequada possível. Para isso, todo hospital deve estar constantemente preocupado com a melhoria da qualidade de sua gestão e assistência, buscando uma integração equilibrada entre todas as áreas funcionantes do hospital, como as áreas administrativa, econômica, tecnológica, assistencial, médica e de pesquisa.

A promoção da eficiência e da eficácia nos processos de gestão é indispensável para assegurar uma assistência melhor e mais humanizada à saúde dos pacientes que procuram os hospitais, necessitados de apoio e cuidados.

O conceito de qualidade aplicado à assistência à saúde pode ser definido como conseguir benefícios com os menores riscos possíveis para o paciente. O desenvolvimento da qualidade pelo hospital não depende exclusivamente do esforço de um grupo de trabalhadores, mas, sim, de todos, pois a qualidade depende muito mais dos funcionários e colaboradores e, consequentemente, dos seus valores do que das metodologias, das técnicas e dos instrumentos utilizados no ambiente hospitalar.

A qualidade hospitalar é um processo que pode ser mensurado utilizando-se diferentes indicadores, e, com base nos resultados, pode-se até mesmo realizar comparações entre hospitais, incentivando a melhoria contínua da qualidade. Essa busca por qualidade necessita de um trabalho contínuo e demanda esforço por parte de todos os envolvidos.

A avaliação da qualidade na assistência à saúde deu-se no início no século XX, em meados de 1924, quando foi formado o Programa de Padronização Hospitalar (PPH), estabelecido pelo Colégio Americano de Cirurgiões (CAC). Nesse programa, para garantir a qualidade de assistência aos pacientes, foi definido um conjunto de padrões relacionados à organização do corpo médico, ao exercício da profissão, e ao conceito de corpo clínico.

No entanto, Feldman, Gatto e Cunha (2005) relatam que esses padrões ainda eram pouco abrangentes, pois levavam em consideração apenas as condições necessárias aos procedimentos médicos e ao processo de trabalho, não considerando, por exemplo, os serviços prestados pela equipe de enfermagem, os elementos da estrutura física do hospital, nem a avaliação dos resultados com os pacientes.

No Brasil, desde 1970 o Ministério da Saúde vem publicando Normas e Portarias com o intuito de implantar um sistema eficaz e capaz de controlar a assistência à saúde no país, garantindo a qualidade hospitalar.

O termo “acreditação hospitalar” passou a ser discutido em 1990, na esfera do Ministério da Saúde. Mas também diversas outras iniciativas podem ser citadas como precursoras da avaliação dos serviços de saúde no Brasil, como o Programa de Avaliação e Certificação de Qualidade em Serviços de Saúde, no Rio de Janeiro; o Instituto de Administração Hospitalar, no Rio Grande do Sul; e o Instituto Brasileiro de Acreditação Hospitalar, em São Paulo.

O Ministério da Saúde instituiu uma comissão nacional para desenvolver o modelo brasileiro de acreditação, o que resultou na elaboração da primeira versão do Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar, publicada em 1998.

De acordo com Rodrigues e Tuma (2011, documento *on-line*), as iniciativas seguiram a seguinte sequência cronológica:

[...] 1991 – CQH – Programa de Controle de Qualidade Hospitalar que possui o apoio da Associação Paulista de Medicina e PNGS – Prêmio Nacional de Gestão em Saúde;

1999 – CBA – Consórcio Brasileiro de Acreditação, agência credenciada a realizar a auditoria pela metodologia da Joint Commission International (JCI);

1999 – ONA – Organização Nacional de Acreditação que surge para ser a metodologia nacional e adequada à realidade brasileira das instituições de saúde.

As mesmas autoras relatam que o termo de gestão pela qualidade nas unidades hospitalares também pode ser utilizado como controle de processos, acreditação, certificação e satisfação do cliente, tendo todos esses termos considerável equivalência entre si. Para essas autoras, acreditação hospitalar é definida como “[...] um processo de certificação voluntária que visa introduzir nas instituições prestadoras de serviços de assistência à saúde, a cultura da qualidade. É realizado por entidade separada e distinta da organização de saúde e normalmente não governamental” (RODRIGUES; TUMA, 2011, documento *on-line*). Com base nessa definição, é possível distinguir as diferenças entre acreditação e certificação.

A acreditação hospitalar tem um caráter mais educativo, sem o intuito de fiscalização ou controle oficial, voltado para a melhoria contínua da assistência à saúde, com envolvimento das comunidades técnica, científica e clínica. O escopo da avaliação é feito pela Norma de Acreditação, e o seu foco mais técnico e suas normas contribuem também para a melhoria na gestão dos laboratórios. Na certificação, a unidade hospitalar passa por uma auditoria que atesta, por escrito, que seus processos, sistemas de qualidade e produtos estão em conformidade com os requisitos, sendo que o escopo é definido pela própria instituição.

2 O processo de acreditação hospitalar

Os processos de acreditação utilizados para a avaliação da qualidade em serviços de saúde se baseiam na relação entre estrutura, processo e resultado para desenvolver suas auditorias.

Quanto à estrutura, são observados os recursos físicos, humanos, financeiros, organizacionais, materiais, tecnológicos e de segurança.

No processo, são consideradas as questões técnicas das atividades realizadas, as normas e os procedimentos operacionais, a capacitação de funcionários, os recursos de informação, o sistema de controle e monitoramento.

No resultado, é avaliado o produto final da assistência realizada, o acesso da população aos serviços, a finalização dos serviços prestados, o impacto na saúde da população e o nível de satisfação dos pacientes usuários.

Os principais benefícios relacionados ao processo de acreditação hospitalar são:

- segurança para os pacientes e profissionais;
- maior qualidade da assistência;
- promoção do trabalho em equipe;
- melhora do clima organizacional;
- monitoramento dos processos e dos resultados;
- melhora do desempenho institucional;
- credibilidade junto à população; e
- caminho para a melhoria contínua.

De acordo com Assis ([201-?], documento *on-line*), a acreditação hospitalar se caracteriza por três etapas:

- [...] 1) Presença de padrões de referência, estabelecidos por peritos ou especialistas na área;
- 2) Visita de avaliadores, em geral um médico, um administrador hospitalar e uma enfermeira. Estas visitas são periódicas, com intervalos de dois ou três anos;
- 3) A avaliação é realizada em toda instituição. O funcionamento de serviços de saúde é caracterizado por ser um sistema complexo, em que diferentes elementos, pessoas ou materiais, se interconectam, de maneira que ocorre uma grande dependência entre as unidades.

Metodologias de acreditação hospitalar

No Brasil, existem distintos processos de acreditação hospitalar desenvolvidos por diferentes organizações; embora apresentem metodologias próprias, a sistemática de avaliação é bastante semelhante entre elas.

Entre os principais programas, estão:

- ONA (Organização Nacional de Acreditação);
- Programa de Controle da Qualidade Hospitalar (CQH) e Prêmio Nacional de Gestão em Saúde (PNGS);
- Accreditation Canada International (ACI);
- Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS);
- Joint Commission International (JCI); e
- National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations (NIAHO).

A ONA é a organização nacional responsável pelo desenvolvimento e pela gestão dos padrões brasileiros, e a sua certificação tem enfoque na segurança do paciente. Os padrões ONA, além de serem referência nacional, também são reconhecidos no exterior devido à sua participação na International Society for Quality in Health Care (ISQua), associação parceira da OMS presente em diversos países, como Estados Unidos, França e Canadá. Em abril de 2019, a ONA atingiu a marca de 800 certificações válidas em território nacional.

De acordo com Feldman, Gatto e Cunha (2005, documento *on-line*), “[...] o processo avaliatório da Acreditação dá-se a partir de padrões previamente estabelecidos, isto é, compara-se o que é encontrado nos serviços com o padrão considerado como referência. Assim sendo, verifica-se se o serviço atinge ou não os critérios preconizados como desejáveis”.

Com base nas normas do Sistema Brasileiro de Acreditação e do Manual Brasileiro de Acreditação, as avaliações de certificação da ONA são realizadas por instituições acreditadoras credenciadas pela organização. Conforme pode ser visto no Quadro 1, existem três níveis de certificação.

Quadro 1. Níveis de acreditação da ONA

Nível 1 Acreditado	■ A organização precisa atender a três critérios: ■ cumprir ou superar, em 70% ou mais, os padrões de qualidade e segurança definidos pela ONA; ■ avaliar todas as áreas de atividades da instituição, incluindo aspectos estruturais e assistenciais; e ■ apresentar certificado válido por dois anos.
Nível 2 Acreditado pleno	■ A organização precisa atender a três critérios: ■ cumprir ou superar, em 80% ou mais, os padrões de qualidade e segurança; ■ cumprir ou superar, em 70% ou mais, os padrões ONA de gestão integrada, com processos ocorrendo de maneira fluida e plena comunicação entre as atividades; e ■ apresentar certificado válido por dois anos.
Nível 3 Acreditado com excelência	■ A organização precisa atender a quatro critérios: ■ cumprir ou superar, em 90% ou mais, os padrões de qualidade e segurança; ■ cumprir ou superar, em 80% ou mais, os padrões de gestão integrada; ■ cumprir ou superar, em 70% ou mais, os padrões ONA de Excelência em Gestão, demonstrando uma cultura organizacional de melhoria contínua com maturidade institucional; e ■ apresentar certificado válido por três anos.

Fonte: Adaptado de Brasil (2020).

3 Indicadores

A fim de se avaliarem os conceitos e as definições de qualidade aplicados à assistência à saúde, devem-se utilizar indicadores, que precisam ser validados para fornecer resultados confiáveis. Os indicadores são variáveis que fornecem resultados quantitativos quanto ao comportamento dos critérios de qualidade estabelecidos pela instituição. Para isso, os indicadores precisam ter uma medida válida em termos estatísticos.

De acordo com Kluck (2009), os indicadores devem apresentar as seguintes características:

- **exatidão**: possibilidades mínimas de erro;
- **confiabilidade**: mesmas medidas podem ser obtidas por diferentes pesquisadores, frente a um mesmo evento;
- **simplicidade**: registros e medidas sem dificuldades;
- **pertinência**: estar correlacionado ao fenômeno ou critério que está sendo examinado;
- **validade**: medir efetivamente o fenômeno ou critério;
- **sensibilidade**: detectar as variações no comportamento do fenômeno que examina.

Os indicadores possibilitam monitorar e avaliar a gestão, a produção e a qualidade do trabalho realizado; além disso, eles podem direcionar a atenção para resultados específicos que devem ser pré-definidos anteriormente pela unidade hospitalar. Esses indicadores são essenciais para verificar se as adequações e exigências propostas para o processo de acreditação hospitalar estão sendo cumpridas conforme o esperado.

Podem-se utilizar indicadores para criar diferentes parâmetros que permitam a avaliação da estrutura física, do meio ambiente, dos processos e dos resultados das áreas. Esses parâmetros avaliados auxiliam na tomada de decisão com o objetivo de uma melhoria contínua a partir da análise das tendências e de comparações com referenciais, que podem ser internos e externos.

Rodrigues e Tuma (2011) listam uma série de exemplos de indicadores objetivos, simples, de baixo custo e com dados fáceis de serem coletados que podem ser utilizados em toda a cadeia da assistência farmacêutica, desde a aquisição de produtos até a dispensação e a atenção farmacêutica ao paciente — conforme pode ser visto a seguir, no Quadro 2.

De acordo com Kluck (2009), os indicadores mais conhecidos e utilizados para avaliar a qualidade da assistência médica prestada em unidades hospitalares são taxa de mortalidade, tempo de permanência, taxa de readmissão imediata, taxa de infecção hospitalar, complicações cirúrgicas e percentual de cesáreas.

Quadro 2. Indicadores para um processo de acreditação hospitalar

Processos da assistência farmacêutica	Indicadores
Recebimento	% de erros na nota fiscal, por fornecedor
	Número de notificações de penalizações emitidas
Aquisição – fornecedores	Novos produtos testados com menor preço
	Taxa de não conformidades na entrega
	Economia gerada por preços negociados
	Valor de compra de itens A da curva ABC
	Giro de estoque
	Compras de urgência
Padronização	Índice de medicamentos não padronizados prescritos
	% de adesão à padronização
Abastecimento	Taxa de erros de inventário
	Taxa de medicamentos em falta
	Valor de produtos perdidos por vencimento
	Índice de não atendimento a unidades clínicas
Educação continuada	Número de horas/homem de treinamento
	Treinamentos técnicos realizados
Farmacovigilância	Notificações de reações adversas a medicamentos
	Notificações de desvios técnicos de qualidade
	Interações medicamentosas identificadas
Dispensação	Número de itens dispensados
	Número de kits cirúrgicos preparados
	Valor dos medicamentos dispensados
	Índice de devoluções
	% de erros de dispensação

(Continua)

(Continuação)

Quadro 2. Indicadores para um processo de acreditação hospitalar

Processos da assistência farmacêutica	Indicadores
Atenção farmacêutica	Índice de erros e erros potenciais
	Pacientes orientados
	% de prescrições avaliadas pelo farmacêutico
	Número de intervenções farmacêuticas realizadas
	Taxa de não aderência à recomendação de adequação da prescrição de antimicrobianos
	Informações sobre medicamentos solicitadas/fornecidas
	Número de pacientes com acompanhamento farmacoterapêutico

Fonte: Adaptado de Rodrigues e Tuma (2011).



Referências

ASSIS, V. C. A importância da acreditação hospitalar: qualidade na assistência à saúde oferecida pelos serviços. [S. l., 201-?]. Disponível em: <http://www.cpgls.pucgoias.edu.br/8mostra/Artigos/SAUDE%20E%20BIOLOGICAS/A%20import%C3%A2ncia%20da%20Acredita%C3%A7%C3%A3o%20Hospitalar%20qualidade%20na%20assist%C3%A2ncia%20%C3%A0%20sa%C3%BAde%20oferecida%20pelos%20servi%C3%A7os.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2020.

BRASIL. Organização Nacional de Saúde. *O que é acreditação*. Brasília, DF, 2020. Disponível em: <https://www.ona.org.br/acreditacao/o-que-e-acreditacao>. Acesso em: 10 mar. 2020.

FELDMAN, L. B.; GATTO, M. A. F.; CUNHA, I. C. K. O. História da evolução da qualidade hospitalar: dos padrões a acreditação. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 18, n. 2, p. 213–219, 2005. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ape/v18n2/a15v18n2.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2020.

KLUCK, M. *Indicadores de qualidade para assistência hospitalar*. CIH Hoefel e colaboradores: controle e prevenção de infecções humanas. Porto Alegre: FAMED/UFRGS, 2009.

RODRIGUES, M. L.; TUMA, I. L. Certificação em farmácia hospitalar. *Farmácia Hospitalar*, v. 14, n. 82, p. 3–24, 2011. Disponível em: http://www.cff.org.br/sistemas/geral/revista/pdf/132/encarte_farmAcia_hospitalar.pdf. Acesso em: 10 mar. 2020.

Leituras recomendadas

BRASIL. Ministério da Saúde. *Manual brasileiro de acreditação hospitalar*. 3. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2002. (Série A. Normas e Manuais Técnicos, 117). Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/acreditacao_hospitalar.pdf. Acesso em: 10 mar. 2020.

CIPRIANO, S. L.; PINTO, V. B.; CHAVES, C. E. *Gestão estratégica em farmácia hospitalar: aplicação prática de um modelo de gestão para qualidade*. São Paulo: Atheneu, 2009.

MAIA, T. P.; ROQUETE, F. F. Um Olhar sobre a Acreditação Hospitalar no Brasil: a Experiência da Joint Commission International (jci). In: SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO E TECNOLOGIA, 11., 2014. *Anais eletrônicos...*. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos14/44420507.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2020.



Fique atento

Os *links* para *sites* da *web* fornecidos neste capítulo foram todos testados, e seu funcionamento foi comprovado no momento da publicação do material. No entanto, a rede é extremamente dinâmica; suas páginas estão constantemente mudando de local e conteúdo. Assim, os editores declaram não ter qualquer responsabilidade sobre qualidade, precisão ou integralidade das informações referidas em tais *links*.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:



SOLUÇÕES
EDUCACIONAIS
INTEGRADAS